

약제 급여 평가 위원회 평가 결과

pilsicainide 25mg, 50mg
(썸리듬캡슐, 한국다이이찌산쿄)

- ☐ **제형, 성분·함량 :**
 - 1 캡슐 중 pilsicainide 25, 50mg
- ☐ **효능 효과 :**
 - 다른 부정맥 치료제를 사용할 수 없거나, 효과가 없는 빈맥성 부정맥
- ☐ **약제급여평가위원회 심의 일**
 - 제9차 약제급여평가위원회 : 2008년 7월 25일
 - 제17차 약제급여평가위원회 : 2008년 12월 19일
 - 중앙심사평가조정위원회 심의일 : 2008년 12월 15일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 급여의 적정성이 있음.

- 신청품은 “다른 부정맥 치료제를 사용할 수 없거나, 효과가 없는 빈맥성 부정맥”에 허가받은 약제로, 허가 대상 중 심방세동 환자에 한하여 동일계열 약제와 간접비교 시 비열등성이 인정되고 비용이 저가이므로 급여의 적정성이 있음.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “다른 부정맥 치료제를 사용할 수 없거나, 효과가 없는 빈맥성 부정맥”에 허가받은 약제로 class Ic이며, class Ic에 해당하는 약제로 propafenone 및 flecainide가 등재되어 있고, 2차 사용 약제로서 가이드라인¹⁾²⁾에 제시된 amiodarone, procainamide 등이 등재되어 있어 진료상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 2차 사용으로 국내에서 허가를 받았고, class Ic에 분류되는 약제임³⁾.
 - 일본 가이드라인에서는 class Ic 내에서 작용 속도(slow Na 채널 차단제: pilsicainide, flecainide 및 fast-intermediate Na 채널 차단제: propafenone)를 구별하여 사용하도록 언급되어 있으나, 이를 제외한 가이드라인에는 해당 내용이 제시된 바가 없고⁴⁾⁵⁾⁶⁾, 실제 임상진료 상황 하에서 적용되지 않으므로⁷⁾, class Ic 약제 내에서 사용 차수의 차이에 대한 임상적 근거가 충분치 않음.
- 제약사에서 급여기준을 요청한 허가 범위 내 심방세동 환자⁸⁾에 대해 상대적 임상적 유용성을 검토한 결과, 동일계열 약제 대비 비열등성이 인정됨.
 - ■■■■■ 신청품을 2차로 사용한 임상시험 결과를 제약사에서 제출하였으나, ■■■■■의 소규모 피험자를 대상으로 수행된 단독임상시험으로 투여기간 및 개선도 측정 방법 등이 명확히 제시되지 않는 등 근거력이 낮았음⁹⁾.
 - 만성 심방세동 환자에서 동율동 유지율을 간접 비교한 결과, 신청품의 효과가 비교 약제 대비 산술적으로 더 높았으며(신청품 34%¹⁰⁾, propafenone 23%¹¹⁾, flecainide 13%¹²⁾; 위약효과 보정), 신청품 투여환자의 유병기간이 다른 약제에 비해 길어, 효과가 과대 추정될 가능성은 적음¹³⁾.
 - 발표된 임상 연구 문헌 참조시 심방세동 외 자료가 부족하므로, 심방세동에 급여기준을 설정하여 임상에서 심방세동에 사용하는 약물선택의 폭을 넓히는 의미에서 필요함¹⁴⁾.

○ 비용 효과성

- 신청품의 허가사항 및 Vaughan-Williams 분류군 등을 고려하면 대체가능 약제 및 비교 대상 약제는 Class Ic인 propafenone 및 flecainide를 2차로 사용할 경우임.
- 허가사항(유지량 중간값)을 고려할 경우, 신청품의 1일 소요비용은 ■■■■■ 원으로 비교약제인 propafenone 및 flecainide의 가중일일투약비용인 ■■■■■ 원보다 저렴함.
- 신청품은 비교약제대비 효과가 유사 혹은 향상되었으나 1일 소요비용이 상대적으로 저렴하므로, 경제성 평가 대상에 해당되지 않음
 - 신청품의 효과(동율동 유지율)를 비교약제와 간접 비교시 효과가 향상된 것으로 제시되었으나, 불확실성을 고려¹⁵⁾하여 비열등하다고 판단하면, 신청품의 투약비용은 비교약제 대비 저가로 비용 효과적임

○ 재정 영향

- 절대재정소요금액을 허가용량기준(유지량 중간값)으로 산출할 경우, 1차년도(2009)에는 약 ■■■■ 억원, 3차년도(2011)에 약 ■■■■ 억원이 되고, 대체약제인 class Ic 약제의 대체로 인한 재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■■ 억원, 3차년도에 약 ■■■■ 억원 절감될 것으로 예상됨¹⁶⁾.
 - 주상병만을 고려하여 추정하였으므로 실제 청구환자수(주,부상병 포함)에 비해 적게 추정될 가능성이 있음.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 일본에만 단독 등재되어있음.

REFERENCE

- 1) ACC/AHA/ESC 2006 Guidelines for the management of patients with Atrial Fibrillation(AF)
- 2) Circulation Journal Vol. 68, Suppl, IV, JCS 2004
- 3) Martindale(2008)
- 4) 내과학 (2006) Harrison' principles of internal medicine vol.1 230장 p.1333-5 (빈맥성부정맥)
- 5) JACC Vol.48, No. 4, 2006
- 6) J Am Coll Cardiol 2006 Sep 5;48(5):e247-346
- 7) 심장내과 심사위원 자문 내용(■■■■■)
- 8) 신청품 대상 임상 문헌(심방세동)에 과거 약제의 투여력에 대한 자료는 제시되지 않았으나, 포함된 환자군이 만성(유지형, sustained, 하기 참고) 심방세동 환자로 질병의 특성 상 울동전환이 어려운 점을 고려하여 이전에 치료제를 투여한 경험이 있을 수 있음.
 - 참고) 최인석, 심방세동: 일차진료의사를 위한 조언, 가정의학회지 제 22권 제 10호 2001
 - 유지형 i) 지속형(persistent): 48시간 이상 지속, 자연적 울동전환이 없음.
 - ii) 영구형(permanent): 인위적 울동전환이 어려움.

- 9) 제약사 제출자료. ()
- 10) American Heart Journal 2000;140(3):e13
- 11) Am J Cardiol 2001;88:640-645
- 12) The American Journal of cardiology December 1, 2989;64:1317-1321)
- 13) 유병 기간이 길수록 심방세동이 안정화되어 약물적 또는 전기적 울동전환에 저항이 커져 반응을 보이지 않음(조정휘, 순환지 2002;32(3):199-204, Moris JJ 등. Ann Intern Med 1966;65:216-31)
- 14) 중앙심사조정평가위원회(2008.12.15)
- 15) 각 문헌에 포함된 환자군의 유병기간이 효과에 영향을 미칠 가능성이 있어, 간접 비교하여 상대적 효과를 비교하는 것에도 불확실성이 존재함(조정휘, 순환지 2002;32(3):199-204.).
- 16) 재정소요비용 추정방법
 - * 대상 환자수
 - ① propafenone 및 flecainide의 청구 환자수 (주상병 고려, 2007년 연간 EDI 지급청구건수 기준, 명)
 - * 1차년도(2009)에는 약 명, 3차년도(2011)에는 약 명으로 증가할 것으로 예상됨.
 - ② 치료실패율(%): 신청품(pilsicainide) 동울동유지 실패율(=100-(1년째 동울동유지율; %))
 - * 신청품의 동울동 유지율(Okishige 등;American Heart Journal. 2000;140(3):e(13))
 - ③ 환자수 증가율(%): 제약사 제시 증가율 이용(심방세동 및 조동 환자수(I48) 평균 증가율 %, 건강보험통계시스템에서 2000~2006년까지의 자료로 추정)
 - ④ pilsicainide의 매년 예상 시장 점유율(% , 2008~2011)
 - * 재정 소요재정 증감액(연간) [= 해당 년도의 대상 환자수×(신청품 1일 투약비용-비교약제의 가중일일투약비용)×365일]